

Manual de bioseguridad y prevención de infecciones

Manual | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Aplicar precauciones a todos los usuarios y controlar exposición a sangre, fluidos, contacto y productos de aseo.

2. Alcance y condiciones de uso

Precauciones estándar y adicionales según evaluación. Técnicas invasivas o respiratorias requieren recursos y competencia específicos.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta responsable	Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.
Ejecutor según proceso	Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia.
Verificador o titular	Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Evaluar exposición de cada tarea sin etiquetar pacientes como limpios o contaminados por s

Evaluar exposición de cada tarea sin etiquetar pacientes como limpios o contaminados por su diagnóstico. Mantener manos, limpieza, barreras, residuos y dispositivos seguros en toda atención.

2. Seleccionar guantes, protección ocular, mascarilla, ropa y otras barreras según contacto o

Seleccionar guantes, protección ocular, mascarilla, ropa y otras barreras según contacto o salpicadura. Los guantes no reemplazan higiene de manos y se cambian entre pacientes y tareas contaminadas.

3. Organizar material limpio y sucio, evitar contacto de celulares y objetos personales con á

Organizar material limpio y sucio, evitar contacto de celulares y objetos personales con área asistencial. No consumir alimentos en atención ni guardar químicos junto a insumos.

4. Ante signos de infección o necesidad de precaución adicional, evaluar viabilidad del consu

Ante signos de infección o necesidad de precaución adicional, evaluar viabilidad del consultorio, ventilación y técnica. Modificar o reprogramar cuando el riesgo no puede controlarse y gestionar valoración necesaria.

5. Para técnicas que generan aerosoles o contacto con mucosa evaluar formación, protección, l

Para técnicas que generan aerosoles o contacto con mucosa evaluar formación, protección, limpieza, entorno y respuesta antes de ofertarlas. No realizar atención invasiva o respiratoria especializada solo por contar con un consentimiento.

6. Ante exposición activar atención clínica y ruta ocupacional de inmediato

Ante exposición activar atención clínica y ruta ocupacional de inmediato. Documentar situación, dispositivo y acciones sin retrasar evaluación por llenar formatos.

7. Revisar adherencia, insumos y capacitación

Revisar adherencia, insumos y capacitación. Analizar infecciones o exposiciones en seguridad del paciente y mantener acciones verificables.

8. Auditar calidad de manos, limpieza y separación por observación

Auditar calidad de manos, limpieza y separación por observación. Una plantilla o certificado de capacitación no demuestra adhesión cotidiana.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Precauciones en todos los episodios.

Protección acorde al riesgo.

Adherencia observada y corrección antes de siguiente paciente.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Tarea y exposición	
Barreras necesarias	
Higiene de manos	
Dispositivo y contacto	
Condición del área	
Incidente	
Atención y remisión	
Reporte laboral	
Seguimiento	
Acción preventiva	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Referencia técnica de infección

OMS, Hand hygiene in outpatient and home-based care (2012), estrategia multimodal y cinco momentos. Referencia técnica para adaptación ambulatoria, no reglamento colombiano ni sustituto de etiqueta o fabricante.

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241503372>

Prácticas seguras

Resolución 3100, 11.1.5: política, actividades, instancia proporcional, identificación, comunicación, infección, eventos y consentimiento, documentación y formación; aplicar los criterios pertinentes al servicio.

<https://www.minsalud.gov.co/salud/prestacion-servicios/Paginas/sistema-obligatorio-garantia-calidad.aspx>

Trabajo y salud ocupacional

Resolución 1732 de 2015, CC SST, D. 1013 de 2016, Ley 1010 de 2006, Ley 1010 de 2006

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576